32. EL APARATO GENITAL INFERIOR

DURACIÓN : 08:54 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video inmersivo sobre el Aparato Genital Inferior, exploramos la embriología de la vagina y el útero, destacando la dinámica de crecimiento posterior que forma estas estructuras esenciales. El equilibrio ginecológico se aborda a través del análisis de los movimientos entre el sacro y el peritoneo, y cómo estas interacciones afectan la salud de los órganos reproductores. Centrándose en desequilibrios como los abortos espontáneos o la endometriosis, el video propone técnicas terapéuticas fascinantes basadas en conceptos de limpieza energética, equilibrio fascial y vínculos transgeneracionales. Este enfoque permite a los profesionales aprender a

EL APARATO GENITAL INFERIOR: ENFOQUE BIODINÁMICO

EMBRIOLOGÍA DE LA VAGINA Y EL ÚTERO

La inserción de la **vejiga** a nivel del **tubérculo de Müller**, situado en el seno urogenital, es esencial. Esta zona comprende la vejiga, la uretra y la unión a nivel de la vagina.

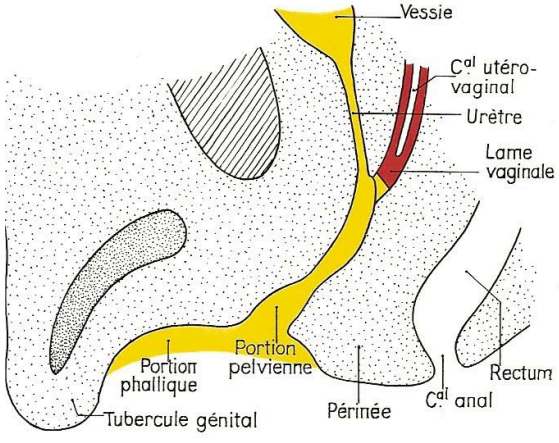


Fig. 2. — *Ouverture de la membrane uro-génitale.*

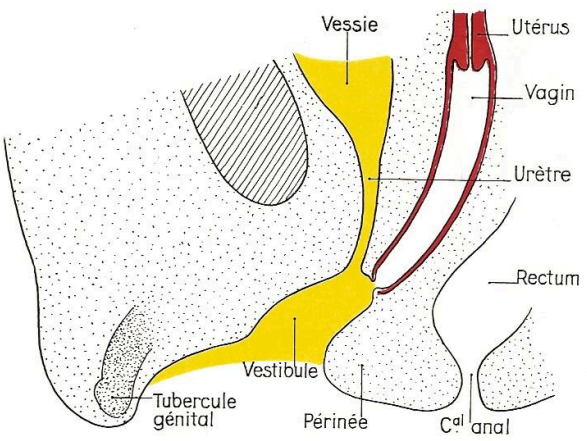


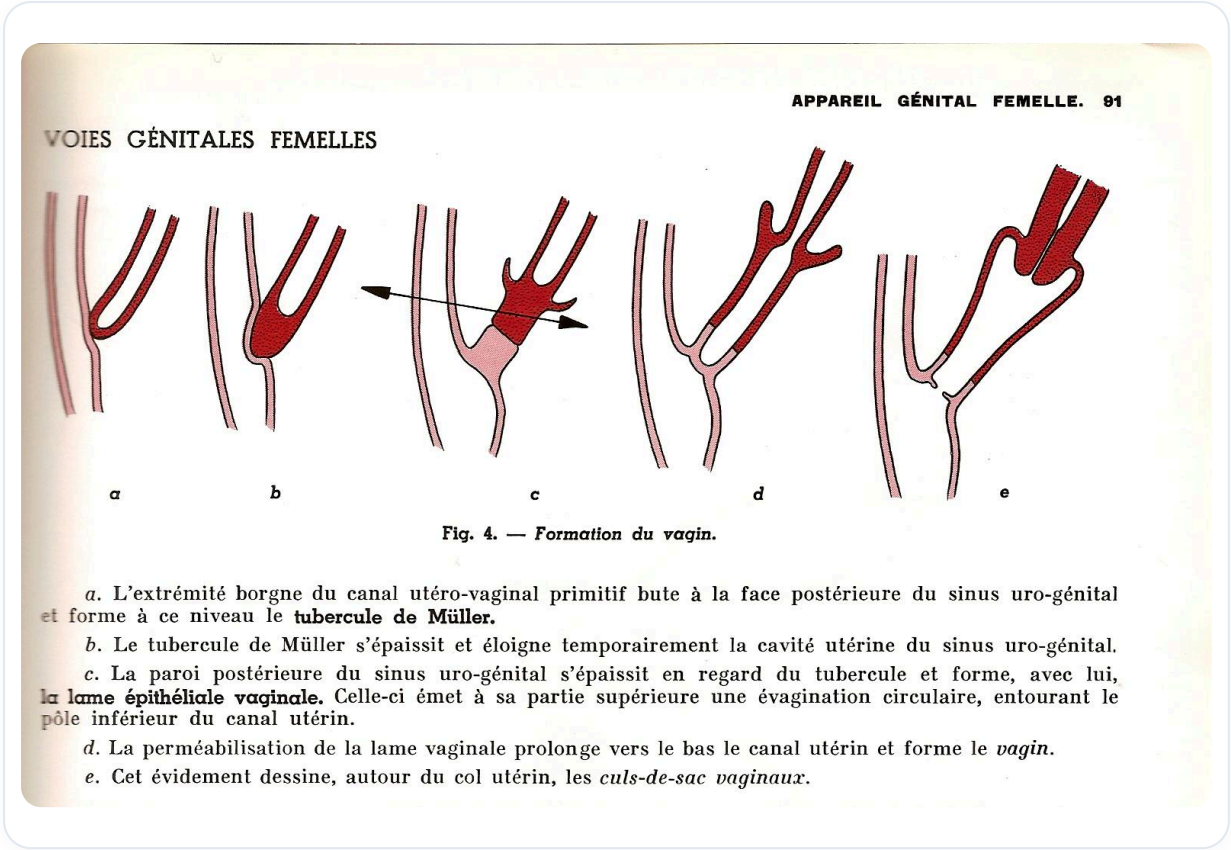
Fig. 3. — *Le vestibule définitif.*

FIG. — Desarrollo del tracto urogenital femenino

La vagina deriva del **mesodermo**, específicamente del conducto de Müller. La formación de las **láminas vaginales** resulta del crecimiento posterior del sacro y del tubo neural.

La velocidad de crecimiento diferencial de esta parte posterior crea el espacio de apertura de la vagina. Es el movimiento **postero-anterior**, entre el riñón y el sacro, el que permite esta extensión.

El tubérculo de Müller se engrosa y luego se estira, no por una tracción superficial, sino por el empuje más rápido de la parte posterior. Este fenómeno conduce al alargamiento y a la formación de la vagina y el cuello uterino.


APPAREIL GÉNITAL FEMELLE. 91

VOIES GÉNITALES FEMELLES

a b c d e

Fig. 4. — *Formation du vagin.*

a. L'extrémité borgne du canal utéro-vaginal primitif bute à la face postérieure du sinus uro-génital et forme à ce niveau le **tubercule de Müller.**

b. Le tubercule de Müller s'épaissit et éloigne temporairement la cavité utérine du sinus uro-génital.

c. La paroi postérieure du sinus uro-génital s'épaissit en regard du tubercule et forme, avec lui, **la lame épithéliale vaginale.** Celle-ci émet à sa partie supérieure une évagination circulaire, entourant le pôle inférieur du canal utérin.

d. La perméabilisation de la lame vaginale prolonge vers le bas le canal utérin et forme le *vagin*.

e. Cet évidement dessine, autour du col utérin, les *culs-de-sac vaginaux*.

FIG. — Vaginogénesis

La pared posterior del seno urogenital se engrosa, dando origen a las láminas vaginales que se abren y se estiran. Esta dinámica es similar, con la parte posterior creciendo más rápidamente.

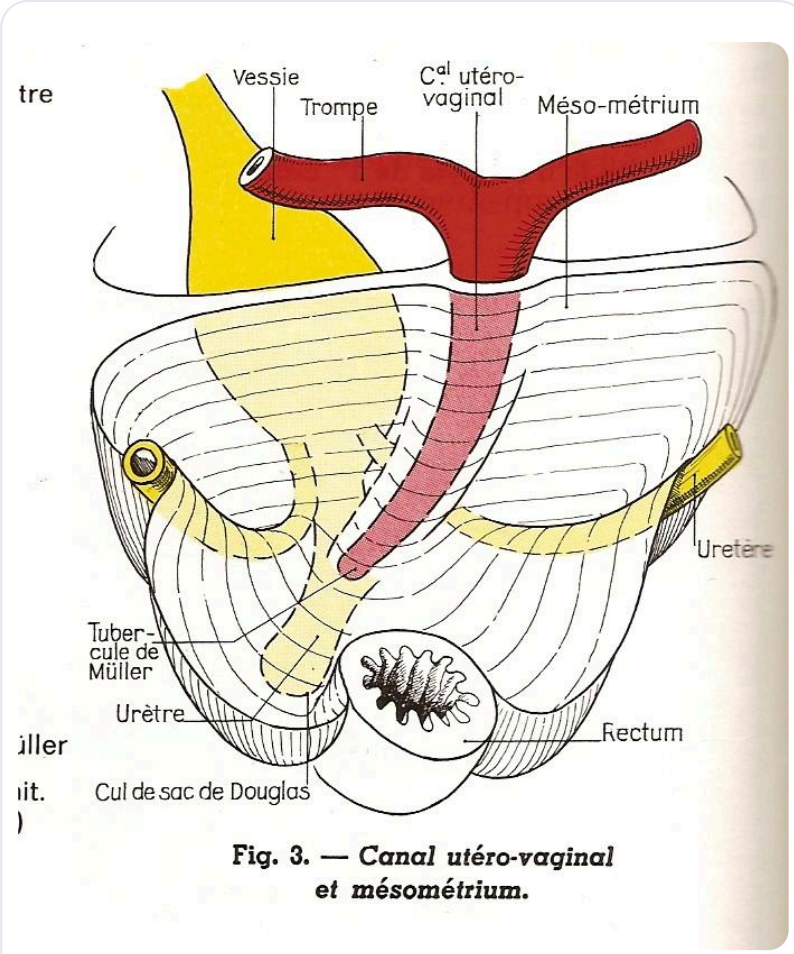


FIG. — Canal útero-vaginal

EQUILIBRIO GINECOLÓGICO Y MOVIMIENTO BIODINÁMICO

Durante el examen del útero, se percibe un movimiento entre el **sacro** y el **peritoneo**. Es en la interacción de estos dos polos donde se encuentran el equilibrio vaginal y uterino.

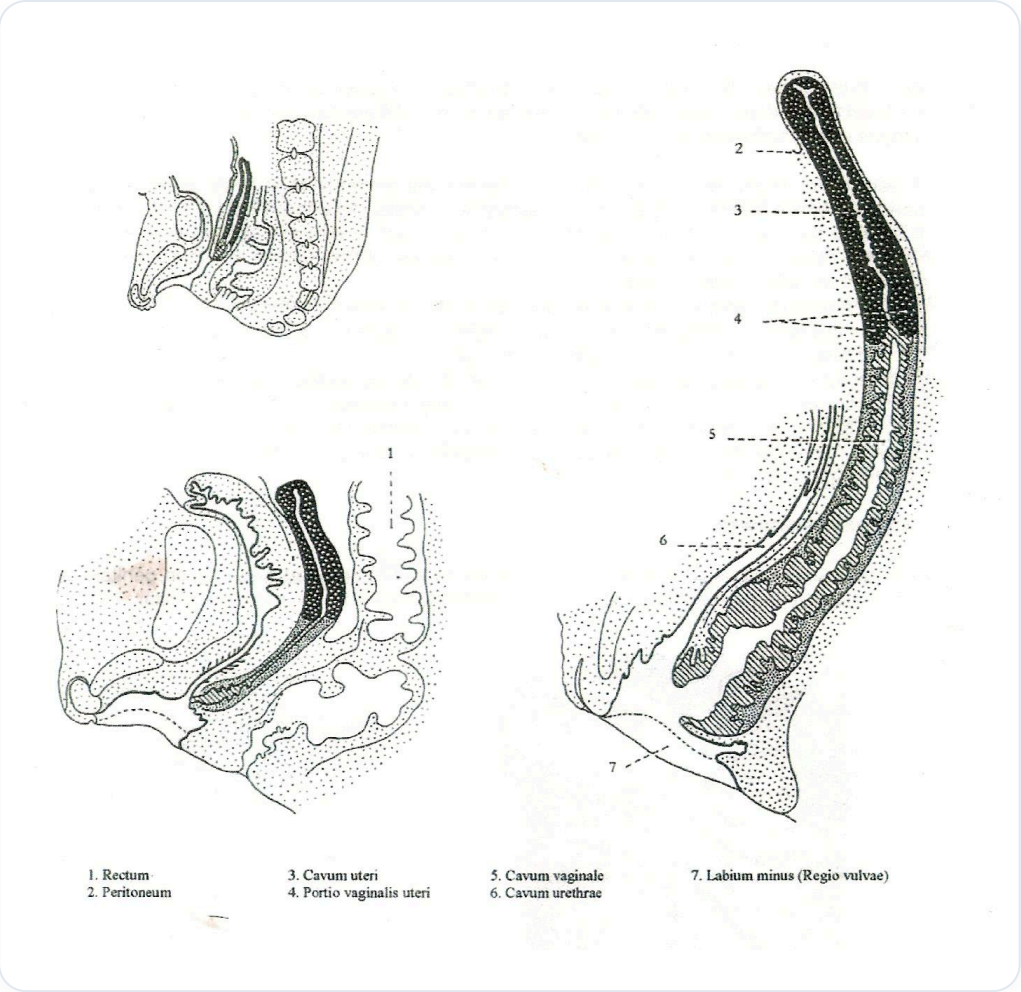


FIG. — Anatomía uterina femenina

A nivel gonadal, se siente un movimiento inverso a nivel del vientre, siguiendo el ligamento en dirección al pubis, como una ola que desciende.

El descenso del sacro está influenciado por el tubo neural. Otro punto de apoyo crucial es la combinación del pubis y el sacro, formando un equilibrio fascial esencial de la pelvis menor en la mujer.

Este equilibrio implica una línea de fuerza descendente relativa al sacro, influyendo en diversas funciones del cuerpo femenino.

ENFOQUE TERAPÉUTICO DE LOS DESEQUILIBRIOS UTERINOS

Situaciones como los **abortos espontáneos** dejan una huella energética en el útero. Una limpieza energética del útero se vuelve entonces necesaria.

Podemos abordar el útero con una **fuerza magnética**, aprendiendo a sentir el campo energético a distancia. El practicante percibe una frecuencia, una zona de calor que se densifica, signo de la energía presente.

Mi enfoque consiste en "escanear" e identificar las zonas que necesitan una limpieza. Se trata de devolver la libertad a los tejidos y a las energías.

Una **retroversión uterina**, por ejemplo, puede provocar fases congestivas. El trabajo a distancia tiene como objetivo reequilibrar el sistema ginecológico, en estrecha relación con la **gastrina**.

La **endometriosis**, caracterizada por una proliferación de tejido que asciende al peritoneo, a menudo se asocia con dolores lumbares y sacroilíacos.

LA CAVIDAD INTRAPERITONEAL Y LA DIMENSIÓN TRANSGENERACIONAL

En la mujer, existe un vínculo directo entre el cuello uterino, las trompas y la **cavidad intraperitoneal**. Esta cavidad es de gran importancia, percibida como un "cielo" o un espacio primordial.

Cada estado del cuerpo representa la mejor respuesta funcional posible en un momento dado. Esta respuesta está influenciada por nuestra vida, pero también por la de nuestros ancestros.

Una retroversión uterina, por ejemplo, puede ser la mejor respuesta que el cuerpo ha encontrado para resolver un problema **transgeneracional** o personal profundo.

Es esencial comprender por qué un patrón transgeneracional se manifiesta así. La terapia tiene como objetivo decodificar esta "mejor respuesta" y ofrecer la liberación necesaria, si se solicita.

El embrión ilustra perfectamente esta noción: en cada etapa de desarrollo, presenta la mejor respuesta fisiológica posible.

LA NEURULACIÓN SECUNDARIA Y LA FORMACIÓN DEL FILUM TERMINAL

El **tubo neural** está asociado a una eminencia caudal posterior, creando un espacio de luz y conexión. Se observa el brote caudal y la parte terminal de la **notocorda**.

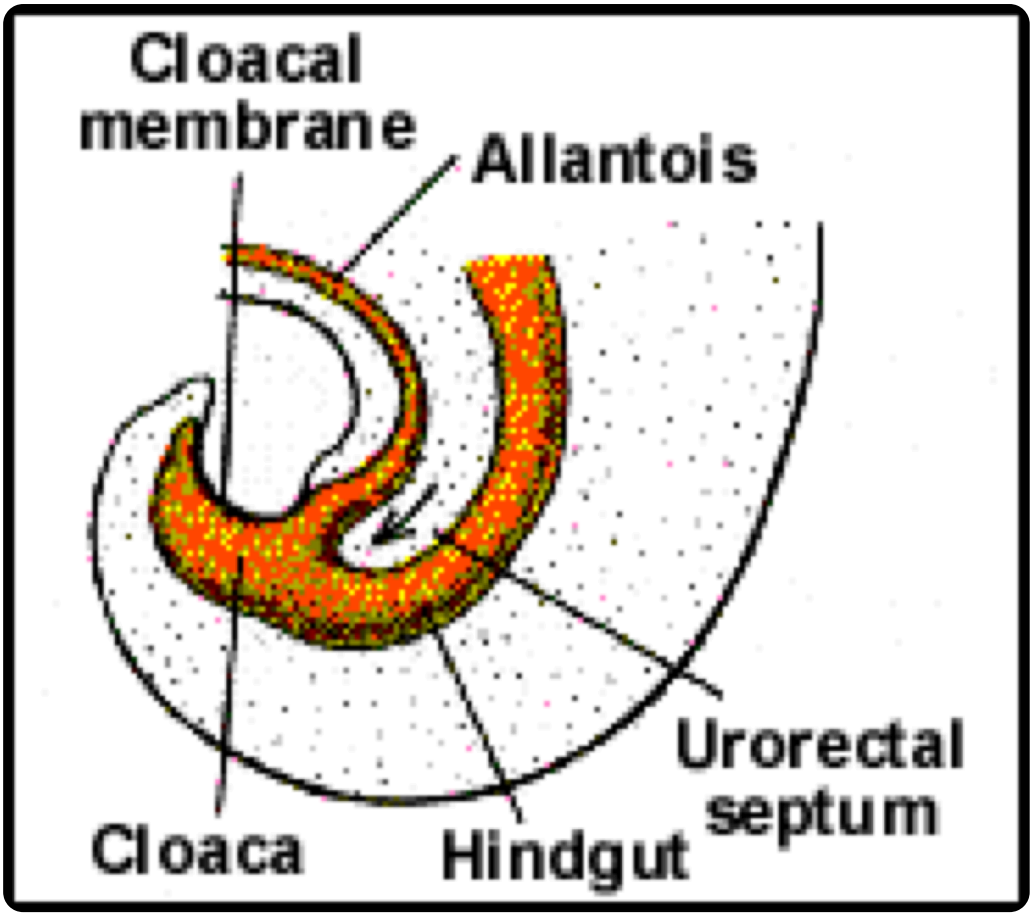


FIG. — Desarrollo cloacal embrionario

El espacio del recto y el tubo neural con el neuroporo posterior están en estrecha relación. Se forma una conexión gracias a un movimiento de desarrollo más pronunciado en la parte posterior.

Esta implica un cierre y luego una reapertura para establecer esta conexión. Este proceso conduce a la emergencia del neuroporo posterior y al alargamiento para formar el **filum terminal**.

Esto es lo que se denomina **neurulación secundaria**. La manipulación del sacro revela estas velocidades de crecimiento diferenciales, donde la unión inicial se alarga posteriormente.

La integración de la eminencia caudal asegura la continuidad con el tubo neural, formando esta neurulación secundaria ascendente.

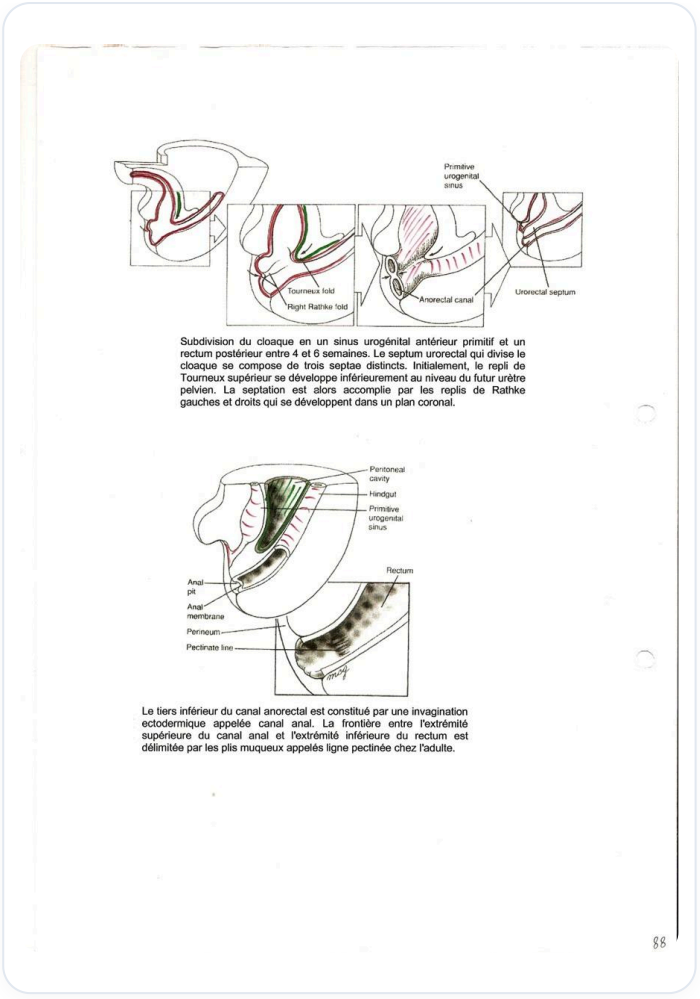


FIG. — Septación de la cloaca

DESARROLLO DEL PERINEO E INFLUENCIA HEPÁTICA

A nivel del **perineo**, observamos la emergencia de los miembros inferiores y una tracción que se ejerce. Este movimiento está profundamente ligado al sistema uterino.

La basculación del **hígado**, en sinergia con el descenso del tubo neural y del sacro, influye en el movimiento de desarrollo que tira hacia la línea alba, a través del ligamento falciforme.

Este desarrollo hepático provoca una basculación que afecta a toda la zona uterina en desarrollo. Podría explicar fenómenos de migración o de tracciones diferenciales ligadas a la posición uterina.

Un ligamento se desarrolla entre el pubis y el ombligo, encapsulando la historia del descenso y de la formación uterina.

Así como el esternón contiene la historia de nuestra flexión, este ligamento ventromedial (en la línea alba) concentra la historia de toda la formación posterior, de la **gonadización** y de la **uterización** de la pelvis.

La línea alba es el encuentro de toda la historia **urogenital**.